

Екатерина ПАУТОВА, IMS

Потребление ГЛС

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОНЛС В 2008 г.

С 1 января 2008 г. финансирование льготного обеспечения лекарствами было разделено на две подпрограммы — ОНЛС (обеспечение необходимыми лекарственными средствами) на региональном уровне, на которое в 2008 г. выделено 30 млрд. руб. (с увеличением финансирования уже 40 млрд. руб.), и закупку на федеральном уровне дорогостоящих препаратов для лечения семи особо тяжелых заболеваний, выделенных в отдельную группу (объем финансирования на 2008 г. — 33 млрд. руб.).

В Федеральную программу «Семь высокозатратных нозологий» вошли препараты для лечения таких заболеваний, как гемофилия, болезнь Гоше, миелолейкоз, рассеянный склероз, муковисцидоз и гипопизарный наннизм и состояние после трансплантации органов. Для сравнения объемов финансирования закупки дорогостоящих препара-

тов в период 2005—2007 гг. препараты, вошедшие в 2008 г. в каждую из нозологий, были сгруппированы и выделены из общего объема поставок. Анализ структуры ДЛО 2005—2007 гг. показал, что вследствие выделения «Семь нозологий» как отдельной Федеральной программы, финансирование закупок высокозатратных пре-



SUMMARY

The revised DLO programme was launched on January 1st 2008. The state-financed pharmaceutical aid to beneficiaries has been separated into two subprogrammes: ONLS (the federal drug reimbursement scheme) on the regional level and the federal budget-financed purchase of expensive drugs for the treatment of the seven most serious diseases placed in a separate list. The «7 most severe nosologies» list includes medicines for the treatment of the following conditions: hemophilia, Gaucher disease, myeloleucosis, multiple sclerosis, mucoviscidosis, hypophyseal nanism and post transplantation maintenance.

Ekaterina PAUTOVA, IMS. DRUG CONSUMPTION THROUGH THE ONLS PROGRAMME IN 2008.

паратов значительно возросло. Это изменение необходимо считать одним из позитивных изменений в сис-

ТАБЛИЦА 1 Структура лекарственного обеспечения необходимыми ЛС по регионам в 2008 г.

Топ-10 субъектов РФ по наибольшему объему поставок			Топ-10 субъектов по наименьшему объему поставок		
Регион	Объем ДЛО, млн. руб.	Доля в общем объеме поставок, %	Регион	Объем ДЛО, млн. руб.	Доля в общем объеме поставок, %
Москва ЦФО	1681,1	15,58%	Чукотский АО ДФО	1,0	0,01%
Московская область ЦФО	728,2	6,75%	Агинский-Бурятский АО СФО	4,9	0,05%
С.-Петербург (не вкл. Лен. обл.) СЗФО	472,2	4,38%	Магаданская область (вкл. Магадан) ДФО	7,0	0,06%
Новосибирская область (вкл. г. Новосибирск) СФО	402,5	3,73%	Респ. Адыгея ЮФО	8,2	0,08%
Нижегородская область (вкл. г. Нижний Новгород) ПФО	392,1	3,63%	Ингушская Респ. ЮФО	10,7	0,10%
Ростовская область (вкл. г. Ростов-на-Дону) ЮФО	350,3	3,25%	Еврейская автономная область СФО	12,2	0,11%
Свердловская область (вкл. г. Екатеринбург) УФО	321,8	2,98%	Респ. Горный Алтай СФО	12,3	0,11%
Пермский край (вкл. г. Пермь) УФО	296,6	2,75%	Карачаево-Черкесская Респ. ЮФО	14,0	0,13%
Краснодарский край (вкл. г. Краснодар) ЮФО	264,5	2,45%	Респ. Калмыкия ЮФО	15,4	0,14%
Челябинская область (вкл. г. Челябинск) УФО	234,5	2,17%	Респ. Тува (Тыва) СФО	18,1	0,17%
Всего ТОП-10	5143,8	47,7%	Всего ТОП 10	103,8	1,0%

РИСУНОК 1 Объем и структура поставок в денежном выражении в 2005—2008 гг.



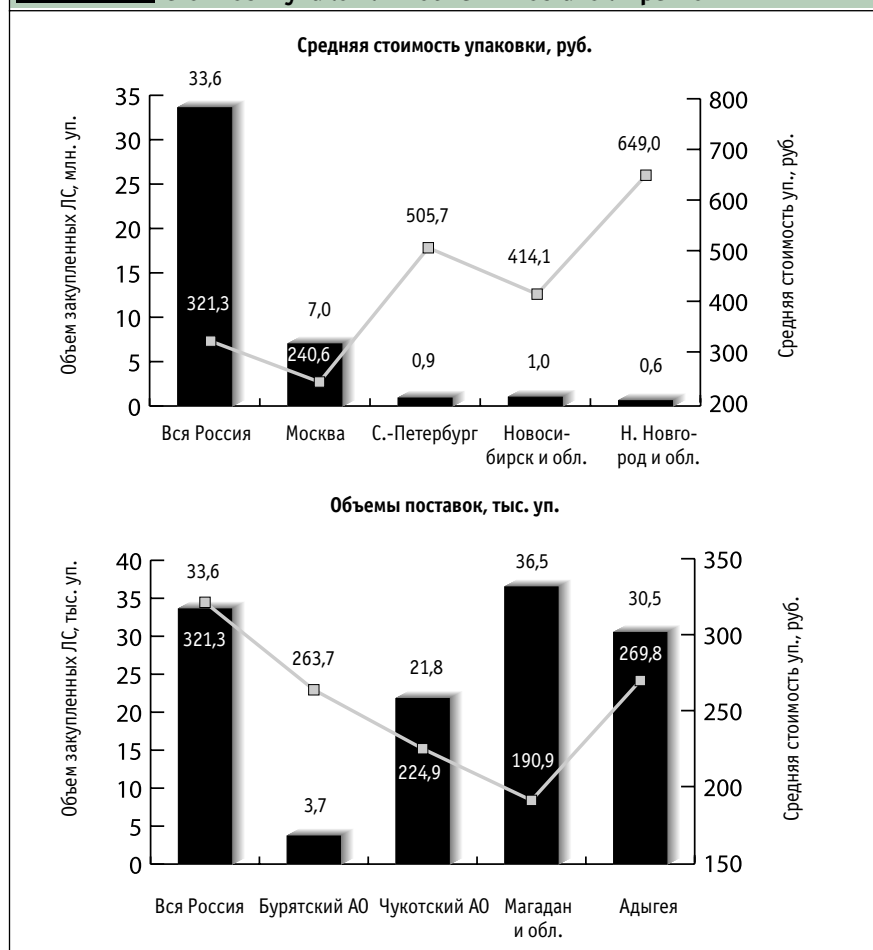
изводители (около 88%). Доля отечественных производителей в общем объеме реализации ОНЛС в 2008 г. составила в среднем по России 12%; в натуральном выражении российские производители аккумулируют порядка 50% объемов поставок. При этом данный показатель может существенно колебаться в зависимости от субъекта РФ: в Московском регионе (г. Москва и Московская область) он достиг 13% (47,8% в уп.), в Волгоградской области составил 10,3% (37,6% в уп.); в то же время в Республике Ингушетия на долю ЛС отечественных производителей пришлось лишь 2% объема финансирования.

Обеспечение необходимыми ЛС в регионах осуществляются в соответствии с общим количеством льготников, что во многом обусловило существующую географию поставок. Значительная часть закупаемых ГЛС приходится на густонаселенные регионы Европейской части РФ (табл. 1). По итогам 2008 г., во главе рейтинга субъектов по объему лекарственного обеспечения находится г. Москва. При этом объем поставок, приходящийся на долю Москвы, значительно превышает уровень своего ближайшего географического «соседа» — Московской области. Совокупно на долю Московского региона приходится свыше 22% всех поставок ЛС. Среди региональных единиц с наименьшим объемом ОНЛС фигурируют субъекты, которые длительное время в экономическом отношении числятся в списке дотационных: Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика.

В 2008 г. в рамках ОНЛС была осуществлена закупка ЛС на основе 1294 МНН, что составило около 1662 торговых наименований препаратов. Ас-



РИСУНОК 2 Стоимость упаковки и объемы поставок в регионы РФ



теме лекарственного обеспечения. Вследствие вышеупомянутых структурных изменений закупка лекарственных средств (ЛС), не попадающих по категории высокотратных, осуществлялась на региональном уровне. В рамках ОНЛС финансирование закупок ЛС по итогам периода 2007—2008 гг. было увеличено на 4%. Таким

образом, общий объем составил 36,5 млрд. руб. При этом в 2008 г. по программе ОНЛС было закуплено на 9% меньше упаковок ГЛС, чем в предыдущем 2007 г.

Рассмотрим подробнее подпрограмму обеспечения необходимыми ЛС в регионах РФ. В структуре поставок по ОНЛС преобладают зарубежные про-

изводители (около 88%). Доля отечественных производителей в общем объеме реализации ОНЛС в 2008 г. составила в среднем по России 12%; в натуральном выражении российские производители аккумулируют порядка 50% объемов поставок. При этом данный показатель может существенно колебаться в зависимости от субъекта РФ: в Московском регионе (г. Москва и Московская область) он достиг 13% (47,8% в уп.), в Волгоградской области составил 10,3% (37,6% в уп.); в то же время в Республике Ингушетия на долю ЛС отечественных производителей пришлось лишь 2% объема финансирования.

Обеспечение необходимыми ЛС в регионах осуществляются в соответствии с общим количеством льготников, что во многом обусловило существующую географию поставок. Значительная часть закупаемых ГЛС приходится на густонаселенные регионы Европейской части РФ (табл. 1). По итогам 2008 г., во главе рейтинга субъектов по объему лекарственного обеспечения находится г. Москва. При этом объем поставок, приходящийся на долю Москвы, значительно превышает уровень своего ближайшего географического «соседа» — Московской области. Совокупно на долю Московского региона приходится свыше 22% всех поставок ЛС. Среди региональных единиц с наименьшим объемом ОНЛС фигурируют субъекты, которые длительное время в экономическом отношении числятся в списке дотационных: Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика.

В 2008 г. в рамках ОНЛС была осуществлена закупка ЛС на основе 1294 МНН, что составило около 1662 торговых наименований препаратов. Ас-

ТАБЛИЦА 2 Топ-10 АТС-групп по объему закупок в рамках ОНЛС в 2008 г.

Рейтинг	АТС-класс	Ведущее торговое наименование в группе	Доля в общем объеме закупок, %
1	A10 [Средства для лечения сахарного диабета]	Лантус, Хумулин НПХ	22,07
2	L01 [Противоопухолевые препараты]	Герцептин, Темодал	8,95
3	R03 [Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей]	Серетид	7,99
4	B03 [Стимуляторы гемопоэза]	Эпрекс, Рекормон	7,23
5	L02 [Противоопухолевые гормональные препараты]	Аримидекс, Касодекс	6,15
6	C09 [Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин]	Лизиноприл, Престариум	5,09
7	N05 [Психотропные препараты]	Рисполепт Конста	4,02
8	N03 [Противоэпилептические препараты]	Топамакс	2,79
9	N06 [Психоаналептики]	Церебролизин, Фенотропил	2,46
10	H01 [Гипоталамо-гипофизарные гормоны и их аналоги]	Сандостатин Лар, Минирин	2,39
	Итого		69,1

сортимент закупаемых ЛС заметно различается в зависимости от географического положения региона. В московском регионе список закупленных препаратов сформирован на основе 500 МНН, тогда как в Агинско-Бурятском АО число МНН было в 2 раза меньше.

Ниже приведен перечень первых десяти АТС-групп второго уровня по объему поставок (табл. 2). Безусловным лидером рейтинга являются А10 [Препараты для лечения диабета] (22,1%). В первой «пятерке» игроков фигурируют АТС-классы противоопухолевых средств: их суммарная доля составила около 15%. В нижней части рейтинга три позиции занимают подгруппы класса N (нервная система): психотропные препараты, противоэпилептические препараты и психоаналептики, коммулятивный удельный вес которых составил порядка 10% общего объема закупок ОНЛС. В целом, по итогам 2008 г. на первые «десять» групп приходится 69% закупок ОНЛС.

Следует также отметить, что средняя стоимость одной упаковки препаратов, поставляемых в рамках ОНЛС в

2008 г., значительно варьировала в регионах. Из первой «десятки» необходимо особым образом отметить г. С.-Петербург (около 506 руб.) и Нижегородскую область (около 650 руб.), в которых зарегистрировано значительное превышение среднероссийского показателя (321 руб.). Еще более значительное расхождение зафиксировано в Республике Ингушетия, там средняя цена на упаковку поставляемого ЛС составила около 1205 руб., что в 3,8 раза превысило средний показатель по РФ.

На общероссийском селекторном совещании по итогам реализации программы обеспечения необходимыми ЛС льготных категорий граждан, которое провел глава Росздравнадзора Николай Юргель, было отмечено, что в субъектах РФ находятся значительные остатки ЛС. По данным на 26 декабря 2008 г., в 19% субъектов остатки превысили полугодовой расход, а в 36% — остатки превысили квартальный расход. Все это является следствием неправильного определения потребности в лекарственных препаратах, нерационального управления то-

варными запасами и нерациональной выписки рецептов¹.

По данным Росздравнадзора, на 30 сентября 2008 г. средняя стоимость рецепта в рамках системы ОНЛС в месяц на одного льготника составила 459,2 руб. при норме 423 руб. (19 мая 2008 г. рецепт оценивался в 438,9 руб.). При этом на начало 2009 г. рецепты для льготников резко подорожали. По сравнению с декабрем 2008 г. в январе 2009 г. рост составил более 17%. Стоимость рецепта превысила отметку 500 руб., увеличившись в феврале до 605 руб.

По оценке экспертов, описанная выше подпрограмма ОНЛС в ее нынешнем виде неприемлема и нуждается в серьезных изменениях, поскольку будет требовать постоянного увеличения финансирования. Подходы к решению накопившихся проблем планируется раскрыть в концепции лекарственного обеспечения, проект которой долгое время обсуждался в Правительстве РФ. В документе должны быть проработаны механизмы лекарственного страхования, которые станут основой для новой программы обеспечения лекарствами льготников.

¹ www.roszdravnadzor.ru/about/news?year=2008.